SERVIÇO DE NEUROLOGIA CLÍNICA E AMBULATÓRIO DE CEFALEIAS — PRONTUÁRIO MÉDICO ELETRÔNICO (DOC-MED-006)

Laudo Neurológico e Conduta Profilática: Enxaqueca Crônica com Aura Visual

ID Prontuário:	**DOC-MED-006**	**Paciente:**	**P-06 (Beatriz Nogueira Cavalcanti)**	**Idade / Sexo:**	42 anos | Feminino
Antropometria:	63 kg | 1,68 m (IMC: 22,3 kg/m²)	**Data/Hora:**	12/11/2026 - 16:00h	**Código CID-10:**	**G43.1 (Enxaqueca com aura [enxaqueca clássica])**

Mapeamento Semântico e Resolução de Entidades (KAG Ontologia): Diagnóstico Canônico: Enxaqueca Crônica com Aura (Aliases: Migrânea com Aura, Cefaleia Enxaquecosa). Causas: Estresse Ocupacional Crônico e Privação de Sono. Fármacos: Propranolol (Betabloqueador), Sumatriptano, Paracetamol (Aliases: Acetaminofeno, Tylenol).

1. ANAMNESE, HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL (HDA) E ANTECEDENTES

Paciente feminina, 42 anos, analista financeira, comparece à consulta neurológica referindo crises recorrentes de cefaleia hemicraniana pulsátil e latejante (alternando lados, com predomínio frontotemporal direito), de forte intensidade (8/10), ocorrendo em média 16 dias por mês nos últimos 4 meses, com duração de 24 a 48 horas quando não tratadas precocemente.

Relata que as crises álgicas são sistematicamente precedidas em 30 minutos por fenômenos visuais reversíveis caracterizados por escotomas cintilantes em zigue-zague (espectro de fortificação) no campo visual homônimo, seguidos de náuseas intensas, fotofobia (intolerância à luz), fonofobia (intolerância a ruídos) e osmofobia. Identifica como fatores desencadeantes diretos o Estresse Ocupacional Crônico de alta demanda e a Privação de Sono (< 5 horas/noite).

2. EXAME FÍSICO DIRECIONADO E PROPEDÊUTICA COMPLEMENTAR

Parâmetro Clínico / Exame de Imagem	Achados Objetivos e Descrição Propedêutica
Sinais Vitais	PA: 122/78 mmHg | FC: 76 bpm | FR: 15 irpm | SpO2: 99% | Temp: 36,5 °C
Exame Neurológico e Pares Cranianos	Paciente lúcida, orientada (Glasgow 15). Pares cranianos II a XII íntegros, pupilas isocóricas e fotorreagentes, fundo de olho sem papiledema. Força muscular grau V global, sem déficits motores ou sensitivos focais.
Sinais Meníngeos e Coordenação	Ausência de rigidez de nuca (Sinais de Brudzinski e Kernig negativos). Provas índex-nariz e calcanhar-joelho normais; marcha atípica ausente.
Ressonância Magnética de Encéfalo com Angio-RM	Parênquima encefálico, sistema ventricular e polígono de Willis dentro dos limites da normalidade, afastando malformações arteriovenosas, aneurismas ou lesões expansivas secundárias.

3. PAINEL DE BIOMARCADORES E EXAMES LABORATORIAIS

Exame / Biomarcador Analisado	Resultado Obtido no Paciente	Valor de Referência / Interpretação
Escala MIDAS (Migraine Disability Assessment)	**26 pontos (Grau IV - Incapacidade Severa)**	0 - 5 pontos (Incapacidade Mínima)
Frequência no Diário de Cefaleia	**16 dias de cefaleia/mês (10 com características de migrânea)**	Critério ICHD-3 para Migrânea Crônica (>= 15 dias/mês)
TSH / T4 Livre	**1,85 mUI/L / 1,12 ng/dL**	0,4 - 4,5 mUI/L (Eutireoidismo)
Velocidade de Hemossedimentação (VHS) / PCR	**8 mm/1ªh / PCR: 0,12 mg/dL**	Afastada arterite temporal
Hemograma e Bioquímica Geral	**Hb: 13,4 g/dL | Plaquetas: 260.000 / mm³ | Creatinina: 0,78 mg/dL**	Dentro da normalidade
Eletrocardiograma de Repouso (Pré-Betabloqueador)	**Ritmo sinusal regular, FC 76 bpm, PR 140 ms**	Sem bloqueios atrioventriculares

4. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO E FISIOPATOLOGIA / ETIOLOGIA (CAUSAS)

A fisiopatologia da Enxaqueca Crônica com Aura (Migrânea com Aura) envolve o fenômeno de Depressão Alastrante Cortical de Leão (onda de despolarização neuronal e glial no córtex occipital responsável pela aura visual), seguida pela ativação do Sistema Trigeminovascular com liberação neurogênica de Peptídeo Relacionado ao Gene da Calcitonina (CGRP), promovendo vasodilatação meníngea e inflamação neurogênica. Os gatilhos etiológicos primários documentados são o Estresse Ocupacional Crônico e a Privação de Sono.

5. PLANO TERAPÊUTICO, PRESCRIÇÃO FARMACOLÓGICA E CONDUTA CLÍNICA

1. Tratamento Profilático Diário de Primeira Linha: Prescrição do betabloqueador não-seletivo Cloridrato de Propranolol 40 mg VO de 12/12h (80 mg/dia) de uso contínuo para redução da excitabilidade cortical e modulação vascular, após confirmação de ausência de histórico de asma brônquica.

2. Tratamento Abortivo Específico da Crise Aguda: Succinato de Sumatriptano (agonista seletivo dos receptores serotoninérgicos 5-HT1B/1D) 50 mg VO ao primeiro sinal da dor, associado ao analgésico Paracetamol (Acetaminofeno / Tylenol) 750 mg VO para controle álgico multimodal.

3. Medidas Não-Farmacológicas: Higiene rigorosa do sono (mínimo de 7,5 horas noturnas), manejo de estresse e restrição de gatilhos dietéticos (tiramina e excesso de cafeína).

[ALERTA DE GRAFO KAG - INTERAÇÕES CRUZADAS ENTRE PRONTUÁRIOS]:

• Contraindicação Cruzada com Pneumologia (Conexão Direta com DOC-MED-003): O fármaco profilático Propranolol prescrito neste prontuário é um betabloqueador não-seletivo (bloqueia receptores Beta-1 cardíacos e Beta-2 pulmonares). Caso um paciente com Enxaqueca Crônica também possua histórico de Asma Brônquica Alérgica (Bronquite Asmática — DOC-MED-003), o Propranolol é estritamente contraindicado, pois induz Broncoespasmo Severo e anula a ação broncodilatadora do Salbutamol (Aerolin).

• Convergência Terapêutica Segura (Conexão com DOC-MED-004): O analgésico Paracetamol (cujos sinônimos Tylenol e Acetaminofeno são resolvidos no nó canônico Paracetamol) é compartilhado como alternativa segura tanto no manejo álgico da Enxaqueca Crônica (DOC-MED-006) quanto na Dengue Clássica com Sinais de Alarme (DOC-MED-004), sem risco de agressão plaquetária ou gástrica.

Autenticação Digital: Junta Médica de Suporte à Decisão Clínica (GraphRAG & KAG Healthcare) | Registro DOC-MED-006 — Validação Completa.